



外感发热病的血分病、伤阴伤阳证的证治

本院中医基本理论教研组

血分病证治

血分病是外感发热病最深入的一层，大都由营分病进一步的发展，以出现耗血、动血为特征，比营分病更为危重。治疗原则应以凉血散血、清热解毒为主。

某些热性病的末期或恢复期，由于邪恋血分，阴液耗损，伤及心肝肾，属血分病的虚证，列入伤阴辨证论治一节讨论。

一、血分热盛

(一) 热盛出血

主证：高热，躁扰，或昏狂谵妄，斑疹紫黑色，或见吐血、衄血、便血，舌色深绛，脉细数。

分析：本证由于血分热盛，迫血妄行，故见出血诸候。舌色深绛与斑疹紫黑，是血分热毒炽盛之征。热毒侵扰心神，轻则躁扰不安，甚则昏狂谵妄俱见。

治则：清热、解毒、凉血。

方药：犀角地黄汤。

出血较多的，可加仙鹤草、旱莲草、紫珠草；斑疹紫黑而面积较大的，可加元参、大青叶、紫花地丁等。神昏谵语，可配服紫雪丹、安宫牛黄丸或至宝丹等。

如见面目皮肤发黄的，与湿温之邪内蕴有关，可加入清热利胆之药，如茵陈、鸡骨草、溪黄草、田基黄之类。

(二) 血分瘀热

主证：夜间高热，口干，但欲漱口而不欲饮，神志时醒时昏，或见谵语，躁动不安，舌色紫晦，脉细数或兼涩象。

分析：本证由于热盛迫血，致血溢于体内而成瘀。舌色紫晦、口干、但欲漱口不欲饮，乃瘀热相结之征，与热病舌质红绛干燥者不同，且与湿温病口渴不欲多饮，而苔黄腻或白腻者亦有别。神志时清时乱，是瘀热内阻伤及心神所致。脉来兼涩，也是瘀热内困之象。

治则：凉血、解毒、散瘀。

方药：犀地清络饮。

本方是在犀角地黄汤凉血解毒的基础上，加入散瘀和清心开窍的药物，使瘀去热清，诸证亦随之而解。

二、气血两燔

(一) 气血俱热

主证：高热，口渴，舌色深绛，苔黄干，或出斑疹，或见衄血，脉数或细数。

分析：舌色深绛，为血分热盛之征，高热、口渴、苔黄干为气分热炽之候，血分证与气分证俱见，故称气血两燔。

治则：凉血清热。

方药：化斑汤。

(二) 火毒炽盛

主证：起病即高热，头痛剧烈，神志不清，或狂躁谵妄，口干咽痛，骨节疼痛，腰痛较剧，或吐血、衄血，斑疹紫黑，舌绛，苔黄焦或黑，或起芒刺，脉洪数或六脉沉细而数。

分析：本证因火毒炽盛，充斥内外，故全身表里具呈严重险恶证候。火毒上攻，则头痛剧烈；火毒内扰心神，则神志不清，或狂躁谵妄诸证俱见；腰为肾之府，毒火流窜肾经，则口干、咽痛及骨节疼痛，腰痛如被杖。舌绛，苔黄焦或生芒刺，脉洪数，皆由热毒炽盛所致。若六脉均沉细而数，则热毒尤为深重。

治则：清热解毒，或兼泻下。

方药：1.清瘟败毒饮；

2.十全苦寒救补汤。

由于病情严重，宜大剂频服。神志昏迷的，当先急服紫雪丹、安宫牛黄丸或至宝丹。

清瘟败毒饮，适用于热毒充斥表里；而十全苦寒救补汤，则适用于热毒已下结于胃肠，腹部胀痛的患者，临床时可分别选用。

伤阴证治

外感发热病的极期或末期，由于邪热灼津过甚，往往出现伤阴证候。轻则肺胃津液受伤，治宜生津润燥，清养肺胃。重则损及真阴，若肾阴受伤，治宜滋养肾阴；若肾阴受伤而至水不涵木，虚风内动，治宜养阴熄风；若心肾阴虚，治宜增液益气安神。

一、肺胃阴伤

主证：低热或无热，咽干口燥，烦闷口渴，干咳无痰，舌红而干，脉细数。

分析：本证以津液受伤为主。胃津受伤，则见咽干口燥作渴。肺津受伤则见干咳无痰而烦闷。阴虚则生内热，故有时出现低热。

治则：清养肺胃，生津润燥。

方药：益胃汤、沙参麦冬汤、五汁饮随证选用。

以上所列三方，均以生津养液为主，属于胃液不足，而兼见胃口不好的，可用益胃汤。肺津受伤而见干咳的，以沙参麦冬汤为主。两方具可配合五汁饮以加强生津润燥的作用。

二、肝肾阴虚

（一）肾阴虚损

主证：低热不退，手足心灼热，口干舌燥，神倦，消瘦。或咽痛耳聋，颧红。舌绛而干，脉细数无力。

分析：此属下焦肾阴受伤过甚，邪少虚多所出现的证候。温热病治疗不当，或素体阴虚，后期往往出现本证。口干舌燥，消瘦为阴液不足之征。低热不退，颧红，手足心灼热，是阴精亏损，阴虚内热的表现。肾为先天之本，精夺则气虚，神失所养，故精神疲倦，肾开窍于耳，少阴脉循喉咙，精不上承，虚火内郁，故或见耳聋咽痛。

治则：滋阴养液。

方药：加减复脉汤。

本证矛盾的主要方面在阴液亏虚，故宜用滋阴养液之法以清虚热。若大便溏，去火麻仁，加生牡蛎；汗多气喘促者，去麻仁加生牡蛎、生龙骨、吉林参、五味子等。

（二）虚风内动

主证：低热，口干舌燥，手足颤动，甚则拘挛。心悸神倦，耳聋，舌颤。脉细数无力，舌绛无苔。

分析：此为水不涵木，以致虚风内动之证。肝藏血主筋，因肾阴亏损，肝失所养，血虚则生内风，故见手足颤动，筋脉失养则见拘挛。其余症状，是心肾阴虚的见证。本证与热盛动风之证虽同属肝风内动，但病理则有虚实之别。热盛动风属实，每与高热、肢厥、神志昏迷等证候同见，手足抽搐，其势较为急剧。本证属虚，常与一系列的阴虚证候同见，仅作手足颤动或作无力的抽搐。

治则：养阴潜阳熄风。

方药：三甲复脉汤或大定风珠。

本证除用加减复脉汤滋阴养液外，再加生牡蛎、生鳖甲、生龟板等以潜镇熄风。如病情危重，气阴两伤，宜用大定风珠加人参以滋阴固脱，熄风潜阳。

三、心肾阴虚

主证：低热不退，手足心热，口干舌燥，齿垢唇裂，心悸，多汗易惊，脉结代。

分析：本证系因肾阴受伤，心血不足，心气亦虚。心血不足则见心悸脉结代，心气不足则多汗易惊。其余各证，为真阴受损之候。

治则：滋阴益气安神。

方药：加减复脉汤加吉林参、五味子、龙齿。

本证用加减复脉汤以滋阴养液，加吉林参益气复脉。配用五味子、吉林参合方中之麦冬以强心敛汗，龙齿潜镇安神定惊。

伤阳证治

伤阳也是外感发热病末期的常见证候。阳气受伤，可因温热病过用寒凉，阳气受损；也可因汗下过甚，伤津耗气。脾肾阳虚则见小便不利，四肢浮肿，治宜温阳利水。若阴阳急剧转变，出现肢冷神疲，汗出脉微的亡阳症状，治宜回阳救逆，如兼见舌绛少苔，为阴竭阳脱之征，治宜救阴固脱。

一、脾肾阳虚

主证：小便不利，四肢浮肿，尤以下肢为甚，恶寒，神倦，头晕心悸。舌淡，脉沉弱。

分析：本证是脾肾之阳气俱虚，而以肾阳虚为主。肾主水，脾主运化水湿，脾肾阳虚，主水和运化水湿的功能减弱，故见小便不利，四肢浮肿。水气凌心，故见心悸。心肾之阳气俱虚，神失所养，故见神倦头晕而脉沉弱。阳虚生内寒，故有恶寒症状。

治则：温阳利水。

方药：温阳利水汤。

本证重点在阳虚，故用附子为主药。生姜温胃散寒水，苓术健脾行水，白芍和阴。凡阳虚水肿，皆可用本方加减。

二、心肾阳虚（阳虚欲脱）

主证：久病不愈，骤然头额出汗，淋漓不止，汗淡粘腻，肢厥身冷，气息微弱，神倦。甚则下利如注，昏沉躁扰，肢冷，或体温反升高，脉微欲绝。

分析：阳虚欲脱即亡阳证。在外感发热病的过程中，或由于误汗伤津，或因泻下过度，严重伤津耗气，以致心肾之阳欲脱；或温热病过用寒凉，阳气受伤，皆可出现亡阳证候。肢厥身冷，气息微弱，下利，神倦，脉微欲绝，是心肾阳虚症状。突然汗出，身反发热，是亡阳证据。头额出汗，汗淡粘腻，是液随气脱。昏沉躁扰，是心神无所主的危候。

治则：回阳救逆。

方药：四逆汤、通脉四逆汤。

四逆汤中的附子温壮元阳，能振奋心肾阳气，以挽救垂绝阳气。干姜、炙甘草主要是温中止利。在用此方时，宜大剂量分多次频服，直至利止汗敛热退才可停药。通脉四逆汤即四逆汤将干姜用量加倍，附子用量酌增，适用于下利不止，身热反不怕冷，脉微欲绝的症状。若脉象沉而不易摸到，可加吉林参以益气复脉。

三、阴竭阳脱

主证：头汗淋漓，肢厥身冷，气息喘促，面色嫩红，舌绛少苔，时而烦躁，时而昏沉，脉微细欲绝。

分析：肢厥身冷，头汗淋漓为阳气欲脱；元阳虚疲，肺气亦随之而弱，化源将竭，故气息喘促。面色嫩红为虚阳外露，舌绛少苔为阴虚之征。时而烦躁，时而昏沉，是阴阳即将离决的危象。

治则：救阴回阳固脱。

方药：四逆汤合生脉散。

此回阳益阴、阴阳两固的方治。四逆汤回阳救逆，生脉散益气生津，敛汗止喘。若汗出不止，烦躁较甚的，可加茯神以交通心肾，牡蛎龙骨敛涩止汗，镇静安神。

病 例

例一

黄×× 男性 36岁 工人

患者于上午发病，发热、微恶风寒、无汗、口渴、全身肢节痠痛，伴有微咳，食欲不佳，小便黄短。舌质正常，苔薄白微黄，脉浮数。体温 39.2°C 。

辨证：风热感冒，邪在卫分。

治则：辛凉解表。

处方：银翘散加减：银花四钱，连翘四钱，薄荷钱半（后下），桔梗三钱，北杏仁三钱，菊花三钱，桑叶三钱，芦根三钱，甘草钱半。

服上方一剂，第二天上午，患者除自觉恶风寒、发热稍有减轻外（体温 38.2°C ），余证同前。舌质略红，苔薄白微黄，脉浮数。

处方：仍按上方加减。银花四钱，连翘四钱，薄荷钱半（后下），桔梗三钱，荆芥二钱，菊花四钱，黄芩三钱，甘草一钱。

当天上午服上方一剂，下午体温又升至 39.5°C ，仍按前次剂量加大一倍，急煎服一剂。晚上体温逐渐降至正常，整夜安睡，次日自觉诸证大减，仍有微咳，微渴。舌质如常，苔薄白微黄，脉浮略数。（当天中午体温回升至 38°C ），仍按昨天上午原方，日服一剂，连服二天，诸证消失而愈。

分析：患者初起发热，微恶风寒，无汗，口渴，身痛，微咳，舌苔薄白微黄，脉浮数等，均属一派卫分表热症状，但小便黄短，热邪已影响气分，初投辛凉解表银翘散加减，未能兼顾气分热邪，且邪气方盛，未能迅速控制病情，次日已见舌质转红，邪渐入里，有卫气同病之势，乃于辛凉解表剂中加入黄芩以清里热。惟因病重药轻，病势仍继续发展，遂将原方倍其剂量，药病相当，病遂向愈。

例二

何×× 女性 9岁

发病已三天，开始时突然发热、头痛、口渴、微有咳嗽、恶心、全身疼痛、疲乏、嗜睡，继而出现惊叫，前来就诊。入院时体温 38°C ，下午升至 40.5°C 。时值八月，该地有“乙脑”流行。

证见：高热神昏，项强，烦渴唇干，面目红赤，抽搐微作，小便自遗，舌质深红苔黄，脉滑数。

辨证：暑温，邪陷心包，气营同病。

治则：清热解暑凉血，开窍通神。

处方：清瘟败毒饮加减。生石膏一两半，滑石五钱，连翘三钱，芦根一两，知母三钱，竹叶三钱，玄参四钱，黄连钱半，水牛角一两半，甘草一钱，紫雪丹五分（冲服）。一剂，渣再煎服。

次日，抽搐不作，身热稍退（ 38.5°C ），倦怠嗜睡，神志模糊。仍照前方去紫雪丹，一剂，煎服法同前，另清心牛黄丸二个，上下午各服一九。

第三日热势继续下降（ $37.5^{\circ}\text{C}\sim 37.8^{\circ}\text{C}$ ），神志已清，颈项柔软，能进稀粥，舌质较红，舌苔薄黄，脉略数。余邪未清，拟清络饮加减以清余热。

处方：丝瓜络三钱，银花三钱，鲜西瓜皮一两，莲叶三钱，芦根一两，冬瓜仁三钱，花粉三钱，竹叶三钱，

桑枝五钱，甘草一钱。日服一剂，连服三天，第四天体温正常，无其他不适，住院五天全愈出院。

分析：患者得病于暑天，发热而渴，不恶寒，面红、舌质深红、苔黄，脉滑数，继而神昏、项强、抽搐，乃暑热兼疫疠之邪侵入气分，迅即入营，以致气营同病；热闭心包则神昏，热极风动则抽搐；故拟清瘟败毒饮加减，气营两清，另用紫雪丹、清心牛黄丸开窍通神，二剂后病势大减，神清进食，舌转淡红，苔转薄黄，脉略数，暑热余邪未清，故转用轻清解暑之清络饮加减，以清余热而愈。

例三

钟×× 男性 41岁 农民

患者于十三天前开始微恶风寒、发热，午后热甚，肢体痠疼疲乏，胸闷不饥（每餐只进稀粥一小碗，稍多则觉腹部胀甚），便溏，小便短赤。

证见：面色淡黄、神倦、懒言，上脘部微胀，有轻度压痛。自诉胸闷、纳呆、不渴，余如上述。舌质略红，苔白腻微黄，脉濡略数。体温38℃（上午九时）。

辨证：湿温，邪留气卫。

治则：宣化淡渗，佐以泄热。

处方：三仁汤加味：北杏仁三钱，苡仁八钱，白蔻仁钱半，滑石八钱，白通草钱半，竹叶三钱，厚朴三钱，法半夏三钱，羌活钱半，桑枝八钱，枳壳三钱，黄芩三钱。

服药一剂，寒热渐减，余证亦见减轻，舌转白腻，原方去黄芩、羌活，加藿香三钱，佩兰三钱，日服一剂，连服四天，诸症消失而愈。

分析：微恶风寒、发热、午后热甚，身痛疲乏，胸闷，纳呆，便溏，舌苔黄腻，脉濡等均属湿温见证，湿性粘腻，治不如法，则留连难愈。外感时令之湿，湿郁热蒸，困于经络，则微恶风寒、发热、身痛、疲乏；湿热内困于脾胃，则胸闷、脘胀、纳呆、便溏、小便黄短等症相继出现；湿热交困，“徒清热则湿不退，徒祛湿则热愈炽”，湿重热轻，故采用三仁汤以芳香化浊，淡渗利湿为主，加枳壳以宽胸消痞，黄芩以清热，羌活、桑枝散表湿，利关节，以治肢节疼痛，使湿热分消，则病可向愈。服药后，寒热已减，舌转白腻，热势虽减，湿未尽除，故去黄芩之苦泄，羌活之表散，加藿香、佩兰以芳化湿浊，使湿邪尽解，脾阳复振，病乃全愈。

例四

麦×× 女性 5岁

因患暑温（乙型脑炎），高热、昏迷、项强，入院治疗七天，已热退神清，略进饮食，惟手足频频颤动。舌绛干无苔，脉细数无力；形体消瘦，神情疲乏，肤色晦暗无华。

辨证：肝肾阴伤，虚风内动。

治则：滋阴潜阳熄风。

处方：三甲复脉汤加减：生牡蛎六钱，生鳖甲六钱，生龟板八钱，炙甘草二钱，生地六钱，麦冬三钱，白芍三钱，火麻仁三钱，五味子钱半，女贞子三钱。

日服两剂，连服四天，诸症消失，精神食欲日增，已能起床缓步行动，乃出院回家调养。

分析：病者初患暑温，高热、昏迷，虽经治疗后暑热已退，惟热伤肝肾之阴，故见舌绛干无苔，脉细数无力，形体消瘦，肤色晦暗。肝肾之阴亏损，不能濡养筋脉，以致虚风内动，出现手足搐搦。方用三甲复脉汤加减，滋阴潜阳，使肝肾之真阴恢复，虚风自熄，而病乃愈。